

3A. Cadera: anamnesis dirigida

Localizar ingle, región lateral o nalga y preguntar por calcetín, coche, decúbito y síntomas lumbares.

Pregunta literal	Si responde SÍ → orienta	Si responde NO → aporta	Qué explorar después
¿El dolor está en la ingle y le cuesta ponerse el calcetín, el zapato o entrar en el coche?	Origen coxofemoral: OA, labrum o FAI.	Reduce cadera intraarticular, sin excluirla.	Rotación interna, log-roll, FADIR/FABER y RX en carga.
¿Cojea o le duele al flexionar o girar la pierna hacia dentro?	OA u otra patología intraarticular.	Reduce OA rígida; no excluye labrum/FAI.	ROM comparativo, especialmente rotación interna.
¿Le duele en el lateral al dormir sobre ese lado o al estar de pie sobre una pierna?	Síndrome doloroso trocantérico/tendinopatía glútea.	Reduce GTPS, especialmente si tampoco duele a la palpación.	Palpación GT, abducción/derotación resistida y apoyo monopodal.
¿El dolor aparece al hacer fuerza para elevar la pierna o subirla al coche?	Iliopsoas o generador intraarticular.	Reduce irritabilidad del flexor, no cadera articular.	Stinchfield, flexión resistida y ecografía del iliopsoas.
¿Tiene dolor lumbar, hormigueos, debilidad o dolor que baja por la pierna?	Columna/radiculopatía; L2-L4 puede referir a ingle/rodilla medial.	Reduce origen neural objetivo.	SLR/femoral stretch, fuerza, sensibilidad y reflejo rotuliano.
¿Nota chasquido, bloqueo o dolor tras un giro/deporte?	Labrum/FAI, iliopsoas dinámico o cuerpo libre.	Reduce síntomas mecánicos, no lesión estructural.	FADIR, log-roll, maniobra dinámica e imagen si cambia conducta.
¿Tiene prótesis, fiebre, dolor nocturno nuevo o empezó tras una caída?	Infección, aflojamiento, fractura o complicación protésica.	Reduce alarma, no la elimina.	RX, analítica y Traumatología; no infiltrar hasta aclarar.

SÍNTESIS DE ANAMNESIS

Dolor inguinal más pérdida de rotación interna aumenta la sospecha coxofemoral. El dolor lateral con decúbito/carga unipodal orienta a glúteos, y el déficit neurológico no debe atribuirse a la cadera.

3B. Cadera: exploración esencial guiada

Un test solo se considera positivo si reproduce el dolor o el síntoma habitual en la localización esperada. Comparar lados cuando sea apropiado y no diagnosticar por una maniobra aislada.

Test	Cómo se hace	Positivo → qué implica	Negativo → qué implica
Rotación interna / log-roll	En supino, comparar rotación interna; para log-roll, rodar suavemente la pierna relajada en rotación interna/externa.	Dolor inguinal o restricción marcada: aumenta sospecha coxofemoral.	Reduce OA avanzada, pero no excluye labrum/FAI u otra patología intraarticular.
FADIR	Flexionar cadera 90°, aducir y rotar internamente de forma progresiva.	Dolor inguinal habitual: test sensible de patología intraarticular/FAI, poco específico.	Un negativo reduce FAI/intraarticular, sin excluirlo por completo.
FABER	Talón sobre rodilla contraria; estabilizar pelvis y descender suavemente la rodilla.	Dolor inguinal: cadera; posterior: SI/lumbopélvico; asimetría apoya restricción.	No excluye cadera ni SI; es localizador, no confirmatorio.
Stinchfield	Supino; elevar pierna recta 20°-30° contra resistencia.	Dolor inguinal: puede ser intraarticular o flexor de cadera; baja especificidad.	Reduce irritabilidad con carga, pero no descarta patología articular.
Palpación GT	Palpar facetas del trocánter mayor y tendones glúteos reproduciendo el dolor lateral habitual.	Dolor focal concordante: aumenta sospecha de GTPS; combinado con abducción resistida es más útil.	Junto con abducción resistida negativa reduce mucho la probabilidad de GTPS.
Abducción / derotación resistida	Resistir abducción; o desde flexión 90° y rotación externa, resistir vuelta a rotación interna.	Dolor lateral habitual: apoya tendinopatía glútea/GTPS; debilidad obliga a valorar rotura o nervio.	Combinado con palpación negativa hace GTPS menos probable.
Apoyo monopodal 30 s	Mantener apoyo sobre lado doloroso hasta 30 s; observar pelvis y dolor.	Dolor lateral habitual apoya GTPS; caída pélvica sugiere déficit abductor, no etiología única.	Reduce GTPS muy irritable; no excluye formas leves.
Cribado lumbar	SLR si dolor posterior; femoral stretch y reflejo rotuliano si ingle/muslo anterior.	Dolor neural concordante o déficit/reflejo asimétrico: apoya origen lumbar L2-S1.	No elimina hip-spine; cadera y columna pueden coexistir.

SÍNTESIS CLÍNICA

Para dolor lateral, la combinación palpación del trocánter + abducción resistida es más útil que etiquetar 'bursitis'. Para hip-spine dudoso, la respuesta a infiltración intraarticular con tarea antes/después discrimina mejor que un PENG.

3C. Cadera: ecografía, bloqueo discriminativo y plan

Para diferenciar cadera-columna, la infiltración intraarticular con anestésico es más apropiada que usar el PENG como “test del generador”.

Plantilla ecográfica básica normal	Qué documentar
Receso anterior	Cápsula sin distensión significativa; contorno cabeza-cuello y cortical visibles.
Iliopsoas	Tendón/bursa sin distensión; dinámica si resalte.
Región lateral	Glúteo medio/mínimo con continuidad; bursas no distendidas; Doppler si procede.
Aductores/recto femoral	Explorar según localización, especialmente en dolor deportivo.
Limitación	Ecografía no valora adecuadamente cartilago profundo, labrum completo ni médula ósea.

Escenario	Prueba/intervención	Lectura
Hip-spine dudoso	Infiltración intraarticular ecoguiada con anestésico local, documentando tarea provocadora antes/después; corticoide solo si también se busca tratamiento.	Alivio claro apoya componente intraarticular; respuesta parcial puede significar generadores múltiples.
OA leve-moderada sintomática	Ejercicio/fisioterapia y AINE si seguro. Corticoide IA puede dar alivio corto.	AAOS desaconseja HA de cadera: no supera placebo en promedio.
Dolor intenso de cadera / perioperatorio	PENG es un bloqueo analgésico de ramas articulares anteriores.	No sustituye al bloqueo intraarticular diagnóstico y puede no cubrir toda la cápsula.
Dolor trocantérico concordante	Carga de abductores; infiltración peribursal/peritendinosa selectiva si dolor impide rehabilitar.	Evitar inyección intratendinosa; el efecto del corticoide suele ser corto.
Prótesis dolorosa	RX inicial + analítica/Trauma según sospecha; otras imágenes guiadas por hallazgos.	No infiltrar hasta excluir infección/complicación protésica.

PLAN BASE	Fortalecimiento de abductores/extensores, movilidad, reentrenamiento de marcha y control de carga durante 6-12 semanas. En OA, el objetivo es mantener actividad; en GTPS, progresar carga del tendón y reducir compresión lateral nocturna.
------------------	--

MENSAJE AL PACIENTE	La infiltración puede ayudarnos a saber cuánto dolor procede realmente de la cadera y, si funciona, abrir una ventana para recuperar marcha y fuerza. Si no cambia su dolor habitual, debemos buscar otro generador en lugar de repetirla.
----------------------------	--

3D. Cadera: pauta práctica

Dosis orientativas para adulto no frágil. Individualizar por edad, peso, embarazo, alergias, función renal/hepática, riesgo GI/CV, anticoagulación y medicación concomitante.

CÓMO PRESCRIBIR

Elegir una sola estrategia analgésica principal, fijar fecha de fin y revisar una tarea funcional. Paracetamol: máximo conservador 3 g/día. No combinar AINE. En paciente de riesgo GI que precise AINE, valorar omeprazol 20 mg/día durante el curso.

Cuadro	Fármaco • dosis	Duración / revisión
OA / dolor mecánico	Ibuprofeno 400 mg/8 h O naproxeno 250-500 mg/12 h si es seguro.	5-7 días; revisar marcha, sueño y tarea elegida.
Rescate	Paracetamol 500-1.000 mg/8 h si precisa (máx. 3 g/día).	3-5 días; utilidad limitada en OA como monoterapia.
GTPS	Diclofenaco gel 11,6 mg/g: 2-4 g, 3-4 veces/día sobre región lateral.	7-14 días junto a reducción de compresión y carga progresiva.

Bloqueo / técnica	Fármaco propuesto	Volumen y guardarraíl
Diagnóstico intraarticular	Lidocaína 1% o bupivacaína 0,25%, sin corticoide.	3-5 mL; tarea de cadera antes/después.
Terapéutico intraarticular	Betametasona depot 1-2 mL o triamcinolona 40 mg + anestésico local.	Total 5-8 mL; imagen, asepsia y aspiración negativa.
PENG	Ropivacaína 0,2% o bupivacaína 0,25%; sin corticoide de rutina.	10-20 mL (habitual 15 mL); posible bloqueo motor, no prueba IA específica.
Bursa trocantérica	Betametasona depot 1 mL o triamcinolona 20 mg + lidocaína 1%.	Total 4-6 mL; evitar tendón glúteo.

REHABILITACIÓN

Fuerza de abductores, marcha, movilidad y control de carga 8-12 semanas; 4-8 sesiones de fisioterapia cuando haya cojera, miedo o déficit técnico.

EVITAR

HA intraarticular en cadera, corticoide intratendinoso glúteo o interpretar un PENG positivo como confirmación automática de cadera intraarticular.